Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Estructura hospitalaria

Bioing. Mónica Baroli
Bioing. Diego Kadur El Ainie
Bioing. Fernando Aguirre

HOSPITAL (definiciones)

La **OMS** define al hospital como una empresa destinada a servir la salud por medio de actividades de restauración, preventivas y fomento, así como por actividades educativas y de investigación.

HOSPITAL (definiciones)

Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Servicios de Salud para Hospitales cuyo texto es el siguiente:

CAPÍTULO I - De los establecimientos con internación: disposiciones generales.

A.- De la denominación

Artículo 1.- Todos los establecimientos sanitarios que proporcionen atención médica integral con internación serán denominados HOSPITALES.

Artículo 2.- Cada Hospital agregará a su denominación la correspondiente a su respectiva especialidad, cuando así correspondiere. Los restantes establecimientos serán considerados Hospitales Generales.

Artículo 3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º, cada Hospital podrá agregar a su denominación el nombre que se determine en homenaje a persona o hecho de interés nacional o internacional.

DECRETO 4790/1972

Facultad de Ingeniería
UNER

Establecimientos de Salud

Ayuda en línea

SISA Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino

Ministerio de Salud Argentina

Capítulo 5.1.1

REFES. Registro Federal de Establecimientos de Salud

- Introducción
- Codificación federal de establecimientos de salud
- Tipologías y categorías de los establecimientos de salud
- Gestión del formulario de establecimiento
- Gestión de las redes de establecimientos
- Instructivos de formularios
- Diccionarios de datos
- Servicios web

Facultad de UNER Ingeniería

Establecimientos de Salud

Para identificar a un establecimiento, definir el perfil de la Institución y crear su código único se utilizan 2 características:

Tipología
Define el tipo de asistencia que brinda (con y sin internación) y la especialidad que tiene (maternidad, pediatría, salud mental, tercera edad, diagnóstico, tratamiento, otras especialidades) un establecimiento de salud .

Categoría
Refiere al nivel de los servicios prestados y se basa en el tipo de atención ofrecida. Define el nivel de resolución según los diferentes niveles de complejidad que el establecimiento pueda afrontar, por ejemplo internación simple o terapia intensiva. Abarca bajo, mediano y alto riesgo, tanto común como especializada.

¿Cómo se define la tipología de un establecimiento?

Con internación:
Establecimiento de salud con internación general (ESCIG)
Establecimiento de salud con internación especializada en pediatría (ESCIEP)
Establecimiento de salud con internación especializada en maternidad/materno infantil (ESCIEM)
Establecimiento de salud con internación especializada en salud mental (ESCIESM)
Establecimiento de salud con internación especializada en otras especialidades (ESCIE)
Establecimiento de salud con internación especializada en tercera edad (ESCIETE)

Sin internación:
Establecimiento de salud sin internación de diagnóstico y tratamiento (ESSIDT)
Establecimiento de salud sin internación de diagnóstico (ESSID)
Establecimiento de salud sin internación de tratamiento (ESSIT)
Establecimiento de salud complementario (ESCL)

Estructura hospitalaria

Sistema asistencial o atención médica hospitalaria: conjunto de servicios que proporciona el personal de salud y que se otorgan al individuo con el fin de promover, proteger, atender el daño, rehabilitar y restaurar su salud, y que requiere de camas para su atención

Sistema administrativo contable

- Gerencial
- De Información
- Técnico
- Docencia e investigación

COMPLEJIDAD

Número y grado de desarrollo de las tareas diferenciadas (**actividades finales**) que integran la actividad global del establecimiento.

Dimensiones

- Tecnológicas
- Física
- Recursos humanos

Facultad de UNER Ingeniería

COMPLEJIDAD

1. Capacitación de RRHH
2. Instrumentos – equipamiento
3. Planta física – instalaciones
4. Organización técnico administrativo

PRESTACIONES: CONJUNTO COORDINADO DE ACTIVIDADES FINALES, INTERMEDIAS Y GENERALES

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

Creado por Resolución Secretarial N° 432 del año 1992 y refrendado por el Decreto N° 1424 del año 1997 y luego por Decreto del P.E.N. 939/00.

El Programa sustentó sus bases en los principios de mejora y adecuación permanente de las herramientas tendientes a garantizar la calidad, tanto de los servicios de salud (directrices de organización y funcionamiento), como en el desarrollo de un sistema de habilitación categorizante conteniendo grillas con estándares para la habilitación y categorización de los establecimientos de Salud con internación, para establecimientos públicos y privados (Resolución Ministerial 1262/06 y Resolución Ministerial 1414/07).

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

El desarrollo de la habilitación categorizante fue refrendado y aceptado para su implementación por el Consejo Federal de Salud CO.FE.SA, en las 24 Jurisdicciones de nuestro país.

En relación a la mejora de la práctica asistencial, al igual que en otros países del mundo y de la región, las áreas de calidad desde el año 2004 han adoptado una visión centrada en la seguridad de los pacientes y la gestión de los riesgos asistenciales.

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

La Seguridad del paciente como centro de la escena asistencial ha implicado que la misma sea un corte transversal a las condiciones de estructura física y tecnologías, recursos humanos, procesos y resultados.

Desde esa perspectiva, y con esa dinámica, se ha emprendido el desarrollo de acciones ligadas a la capacitación, sensibilización, investigación y gestión de mejoras de los riegos sanitarios en los ámbitos provinciales

Facultad de Ingeniería UNER

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

El Decreto PEN N° 178 del año 2017 ratifica la vigencia del Programa, en la búsqueda de promover el desarrollo de procesos para asegurar la calidad de los servicios de salud para toda la población y garantizar la equidad en la atención médica, en el marco de la estrategia de la COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD (CUS).

La Resolución 856-E/2017 actualiza los ejes conceptuales del programa y en esa perspectiva se articulan las diferentes acciones que se realizan, que tienen por objeto el diseño de instrumentos, la capacitación, sensibilización, investigación y gestión de mejoras de los riesgos sanitarios en los establecimientos de todo el país.

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

Primer nivel de atención o atención primaria: son los centros que se ocupan de las acciones para prevenir enfermedades, atienden las patologías más frecuentes y menos graves y tienen una relación directa con la comunidad. Ejemplos de primer nivel: Centros de Salud, Centros Comunitarios, Salas de Primeros Auxilios.

Segundo nivel de atención: hospitales generales -con áreas programáticas- (son zonas geográficas con una población definida que está a cargo de un hospital general) que atienden pacientes derivados de los "Centros del Primer Nivel de atención" y se ocupan del diagnóstico y del tratamiento de patologías que no pueden ser solucionadas en ese nivel.

Tercer nivel de atención: hospitales o centros especializados en donde se tratan patologías más complejas que exigen técnicas de diagnóstico y tratamiento sofisticadas.

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM)

RM 900 E /2017

Tipologías de Establecimientos de Salud y los Criterios Básicos de Categorización de Establecimientos de Salud. Incorporación al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Registro Federal de Establecimientos de Salud REFES.

Adhesión de la provincia de E. Ríos

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Adhiérase la PROVINCIA DE ENTRE RIOS al PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA, en virtud de lo establecido en el Artículo 5° -Inciso h) del Decreto N° 578/93 MSAS.-

ARTICULO 2°.- La SECRETARIA DE SALUD, a través de sus órganos técnicos, tendrá a cargo, a los efectos de la Categorización; habilitación y acreditación de Establecimientos de Atención Médica en el territorio Provincial, cualquiera sea su naturaleza; la evaluación y supervisión del cumpliniento de las normas legales que dan marco jurídico al Programa respectivo.-

Criterio de categorización por niveles de riesgo

Bajo riesgo_ Nivel I

- Constituye esencialmente la puerta de entrada a la red de servicios o sistema en la mayor parte de los casos.
- Realiza acciones de promoción y protección de la salud, así como el diagnóstico temprano de daño
- Atención de la demanda espontánea de morbilidad percibida, búsqueda de demanda oculta, control de la población e internación para la atención de pacientes con bajo riesgo con mecanismos explicitados de referencia y contra referencia.

Criterio de categorización por niveles de riesgo

Mediano Riesgo - Nivel II

- Realiza las mismas acciones que en el bajo riesgo, a los que se agrega un mayor nivel de monitoreo y seguimiento para aquellos procesos mórbidos y/o procedimientos diagnósticos y terapéuticos que exceden la resolución del bajo riesgo con mayor intensidad en el seguimiento de la evolución de los pacientes.

Criterio de categorización por niveles de riesgo
Según Resolución N° 900-E/2017

Alto Riesgo con Terapia Intensiva - Nivel III A

Puede realizar acciones del bajo y mediano riesgo

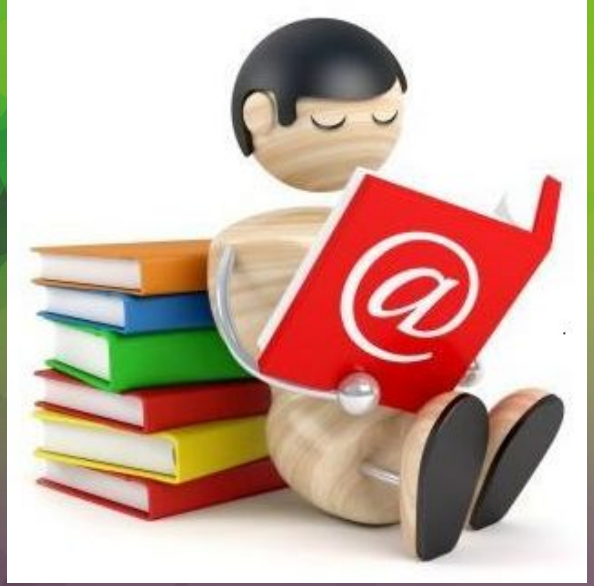
Debe estar en condiciones de resolver total o parcialmente aquellos procesos mórbidos y/o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que requieran para su supervivencia de atención médica y de enfermería en forma constante.

Debe tener capacidad de soporte actual o potencial inmediato de la función de un órgano vital y/o la necesidad de efectuar procedimientos especiales de monitoreo continuo, diagnóstico y/o terapéuticos que preserven la vida.

Criterio de categorización por niveles de riesgo
Según Resolución N° 900-E/2017

Alto Riesgo con Terapia Intensiva Especializada - Nivel III B

Similar al nivel III A con la especificidad de tener capacidad de resolver ciertas patologías que requieran acciones asistenciales complejas y específicas.
Ejm: cirugía cardiovascular, neuroquirúrgica, quemados, trasplantes entre otras.



Preguntas?

